

GESTION DES UNIFORMES MÉDICAUX: CAS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF DE MONTRÉAL

ESG UQÀM

RAPPORT DE PROJET INTÉGRATEUR
PRÉSENTÉ
COMME EXIGENCE PARTIELLE
[POUR LE MBA MODULE 3]

PRÉSENTÉ PAR:
DONGMO EMMANUELLE CARINE
SIÉ ERNEST KONATÉ
IBRAHIMA BEN MADY
KHADIM GUEYE

Sommaire

Introduction

- **Historique de HGJ**
- **État actuel**
- **Problématique**
- **Analyse des écarts**
- **État attendu**
- **Approche solution**

Conclusion

Introduction

Comprendre les raisons de l'indisponibilité des scrubs dans un hôpital et proposer des solutions pour résoudre ce problème.

Le contexte est celui d'un Hôpital Général Juif où les employés sont insatisfaits de la disponibilité des uniformes médicaux aux points d’utilisation sur les étages.

Le projet comprend une analyse de performance, une analyse des opérations, une revue littéraire des solutions existantes, une proposition de solutions et un suivi du projet.

La pandémie de COVID-19 a également accentué les problèmes déjà existants dans l’Hôpital Général Juif (HGJ).

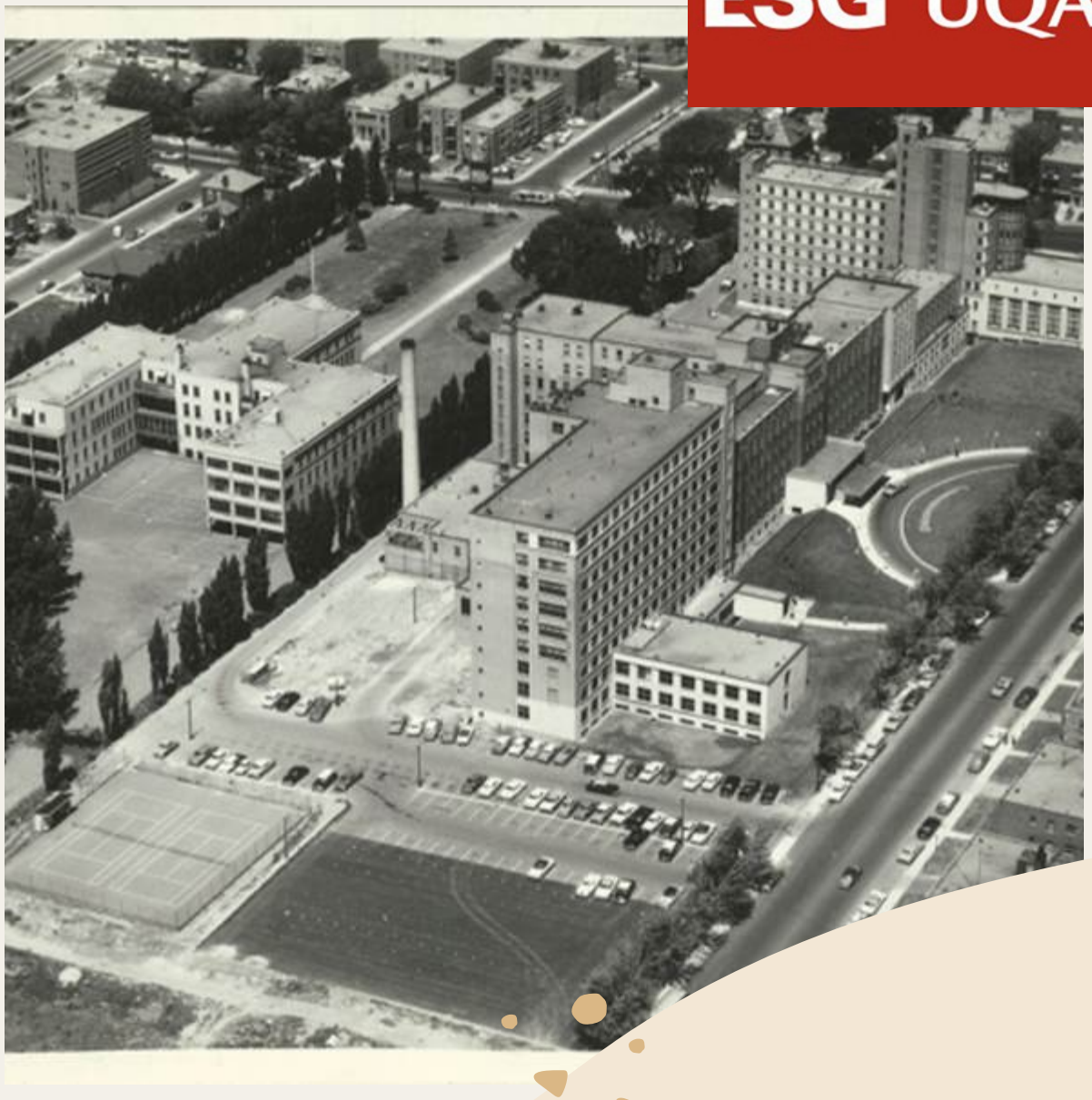
Le projet a pour objectif final de redonner confiance dans le processus de distribution des scrubs.

Historique de HGJ

Fondé en 1904 par des membres de la communauté juive de Montréal.

En 1926 achat d’un terrain et construction d’un nouvel établissement de 5 étages. Et en 1929, l'hôpital ouvre ses portes à la communauté.

Au cours des années 1950 et 1960, l'hôpital a continué à se développer et a ajouté des services tels que la chirurgie, la pédiatrie et la gynécologie.

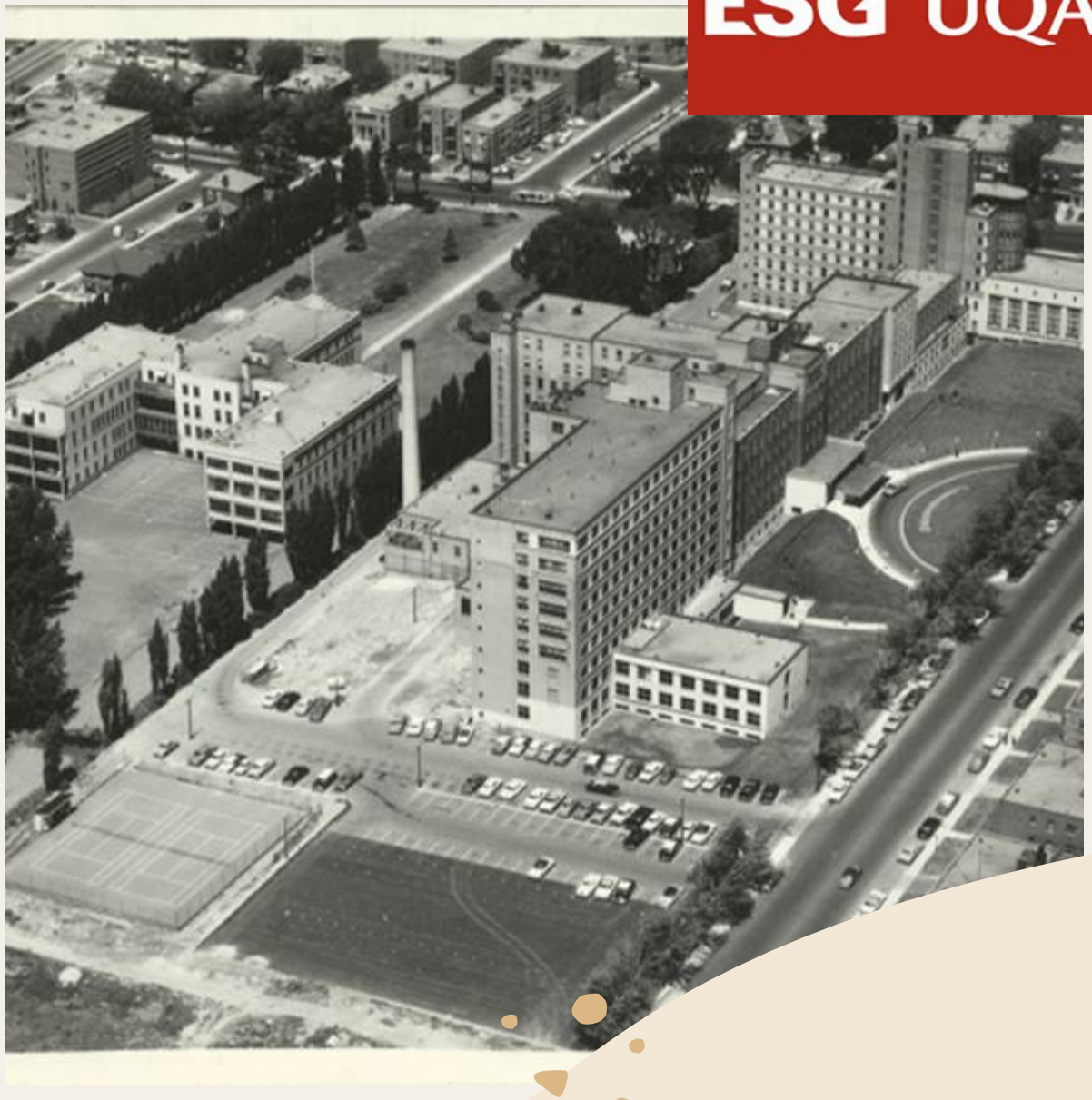


Historique de HGJ

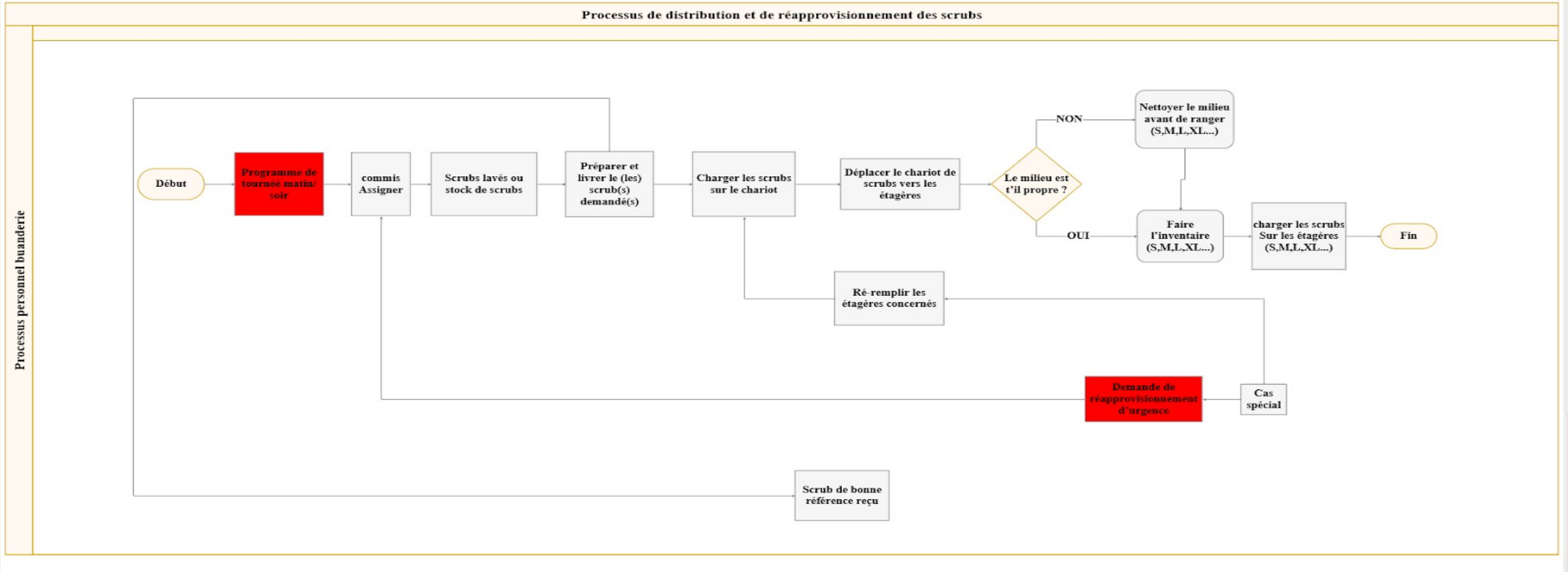
L'hôpital fut affilié à l'université de McGill depuis le début de sa création.

En 1969, l'hôpital a fondé l'
Institut Lady Davis pour la recherche médicale, qui lui est affilié. L'institut est aujourd'hui un des centres de recherche les plus importants et les plus influents du Canada.

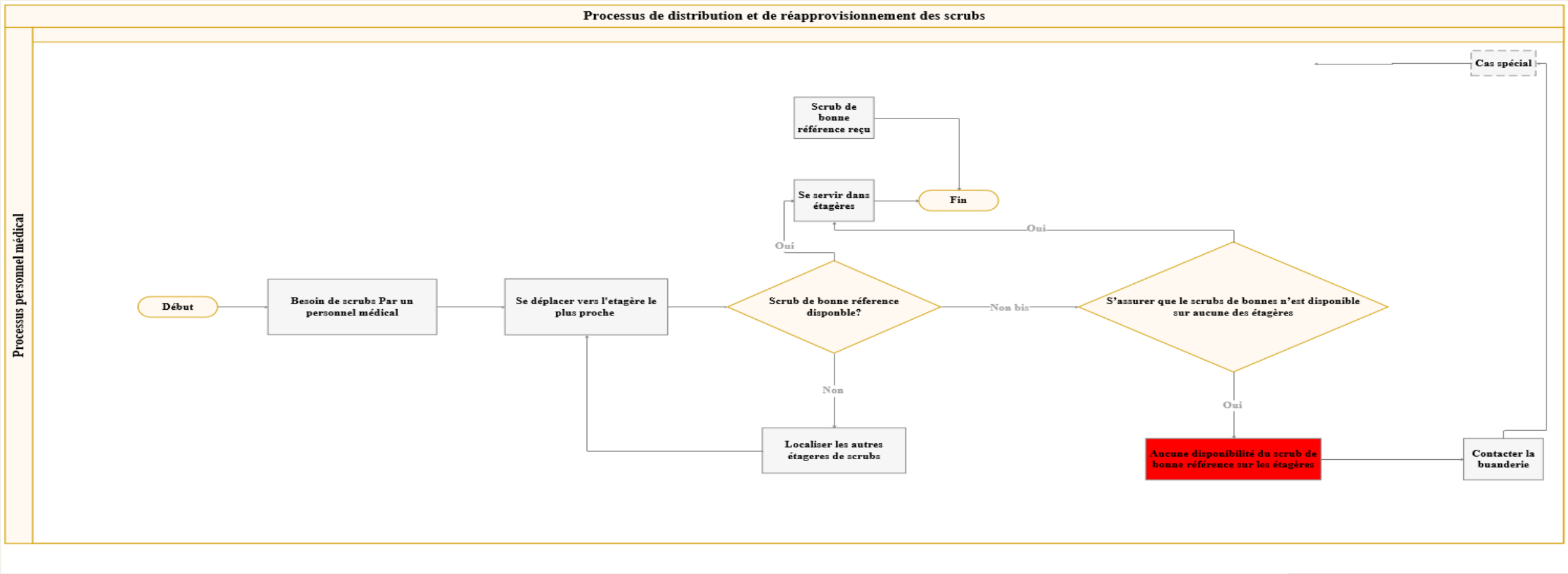
Actuellement, l'Hôpital compte 650 médecins traitants, 1441 infirmières et infirmiers et un nombre total d'employés s'élevant à 4869.



État actuel


Processus de distribution et de réapprovisionnement des scrubs
Processus personnel buanderie
Début
Programme de tournée matin/ soir
commis Assigner
Scrubs lavés ou stock de scrubs
Préparer et livrer le (les) scrub(s) demandé(s)
Charger les scrubs sur le chariot
Déplacer le chariot de scrubs vers les étagères
Le milieu est t'il propre ?
NON
Nettoyer le milieu avant de ranger (S,M,L,XL...)
OUI
Faire l'inventaire (S,M,L,XL...)
charger les scrubs Sur les étagères (S,M,L,XL...)
Fin
Ré-remplir les étagères concernés
Demande de réapprovisionnement d'urgence
Cas spécial
Scrub de bonne référence reçu

État actuel


Processus de distribution et de réapprovisionnement des scrubs
Processus personnel médical
Cas spécial
Scrub de bonne référence reçu
Se servir dans étagères
Fin
Oui
Oui
Début
Besoin de scrubs Par un personnel médical
Se déplacer vers l'etagère le plus proche
Scrub de bonne réference disponble?
Non bis
S'assurer que le scrubs de bonnes n'est disponible sur aucune des étagères
Non
Oui
Localiser les autres étageres de scrubs
Aucune disponibilité du scrub de bonne référence sur les étagères
Contacter la buanderie

État actuel





Problématique

Mécontentement du personnel de l'hôpital causé par une mauvaise gestion et de distribution des scrubs. Ce qui pousse ce même personnel à se servir le plus possible en cas de forte demande.

Occasionnant ainsi des pénuries fréquentes de scrubs au service de la buanderie.



Analyse des écarts

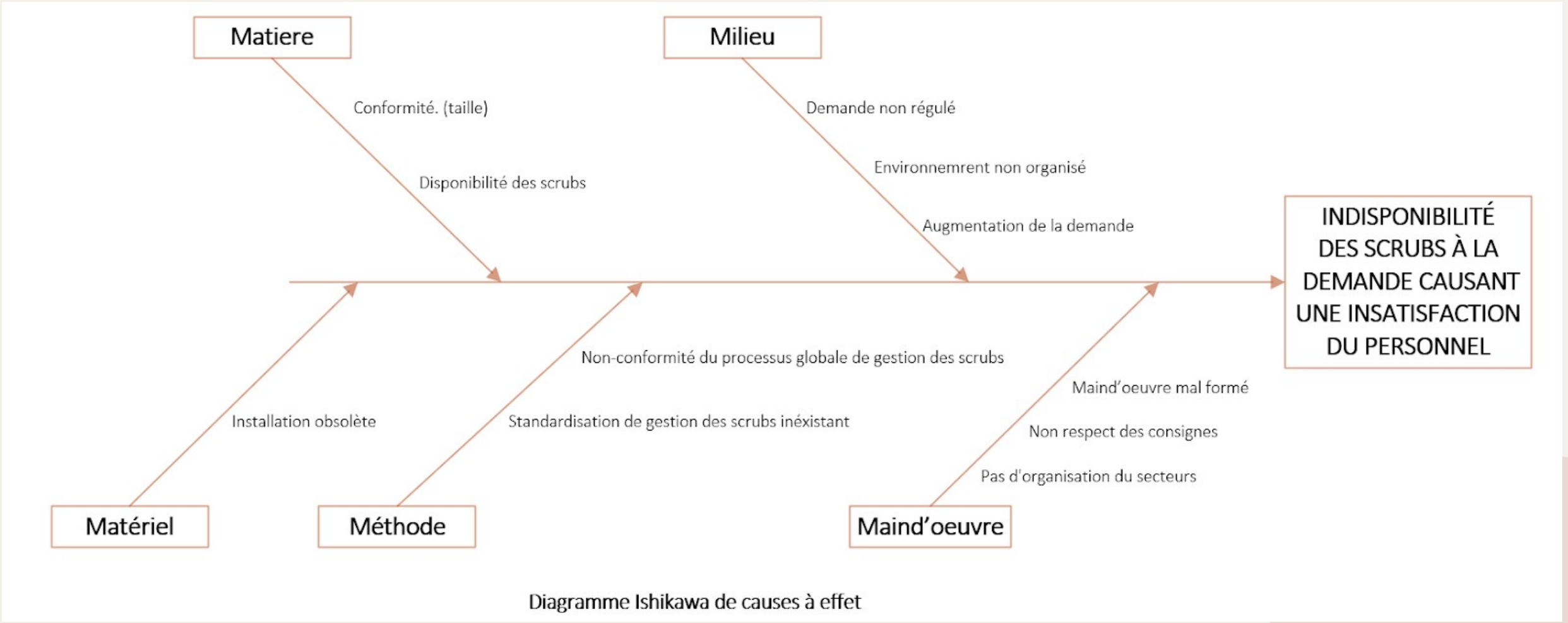
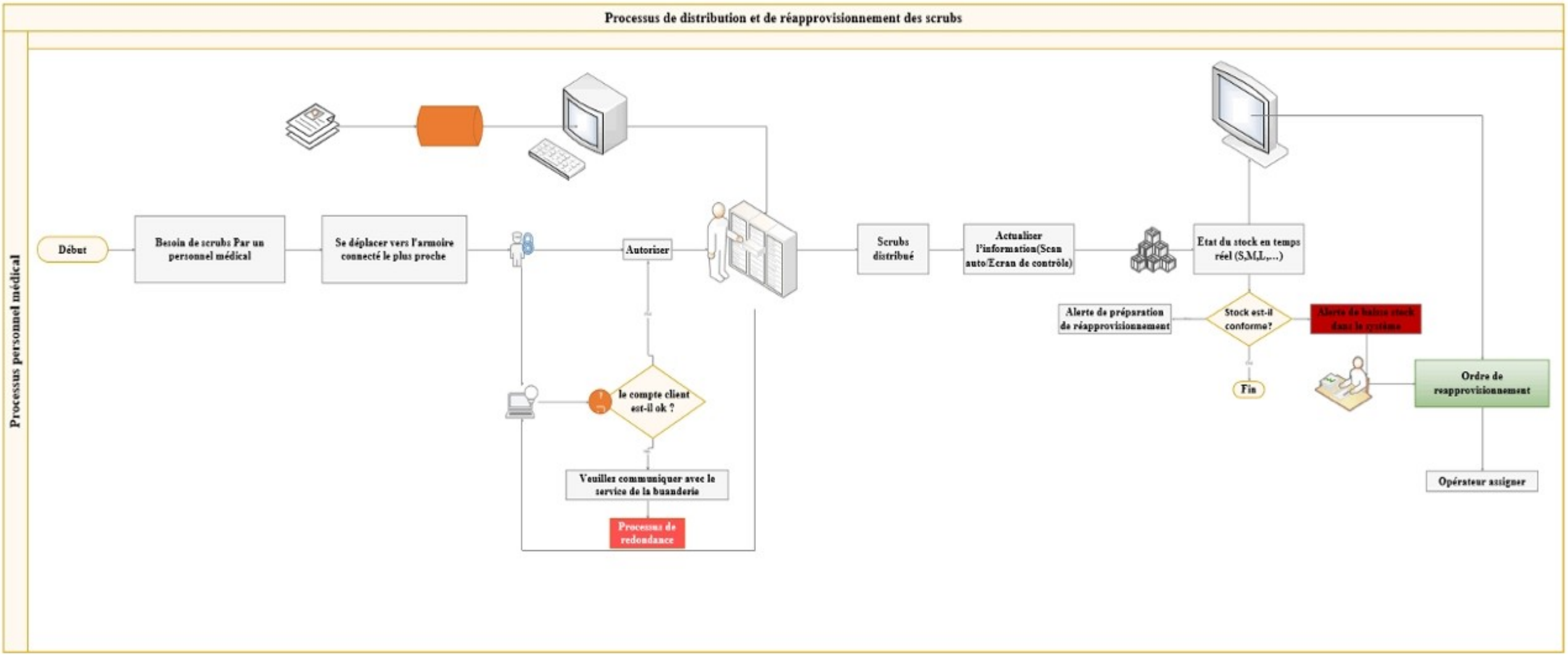


Diagramme Ishikawa de causes à effet

État attendu



Approche solution

- ❑ Solutionnement Basique (sensibilisation et conscientisation de tous);
- ❑ Solution connectée :
  - ❖ Armoire connectée avec tags RFID
  - ❖ Carrousel de gestion de tenues avec tags RFID

Approche solution

La sensibilisation

Faire comprendre au personnel de santé l'importance de bien utiliser les scrubs et de suivre les instructions concernant la distribution.



Approche Solution

Armoire connecté avec tags RFID

Permet aux employés de l'hôpital de récupérer des scrubs propres en utilisant une carte d'accès ou un code personnel. Il comprend:

- système de gestion d'accès
- système de gestion de stock
- système de gestion des transactions



Approche Solution

Système de gestion et de convoyeur de tenues «carrousel»

Convoyeur de tenues avec un aménagement intelligent de stockage de vêtements, associée à un collecteur de linge sale.

Système équipé d'un dispositif de lecture RFID.



Estimation du coût de la solution

Solution\ Critère	**Basique (sans apport technologique)**	**Ensemble solution connecté**	
		Armoire connecté avec RFID	**carrousel de GESTION DE TENUES AVEC RFID**
Espace	Local disponible	l’implantation nécessite peu d’espace	un grand espace d’implantation
Coût	Nécessite peu d'investissement	15000-25000 $	Environ 75000 $

Conclusion

Le travail de session a traité les points suivants:

- Problématique de l'insatisfaction du personnel de l'hôpital général juif en raison du manque de scrubs sur les étagères.
- Processus d'approvisionnement non standardisé et surstockage des étagères en raison d'une politique de libre-service pour les employés.
- Manque de traçabilité des scrubs, ce qui entraîne un écart dans le stockage réel.
- Solution proposée : utilisation de modèles de puces RFID sur les scrubs avec des armoires RFID et des modèles de carrousel.
- Implantation d'une base de données pour rassembler les informations des employés.
- Combinaison des deux modèles proposés pour la solution finale à savoir:
  - Implantation des armoires RFID dans les blocs opératoires pour les chirurgiens.
  - Implantation des carrousels dans chaque étage de l'hôpital pour les autres employés.

Références

Operations and Supply Chain Management for MBAs, 7th Edition - Jack R. Meredith, Scott M. Shafer (Wiley).

Ageron B., S. Benzidia and M. Bourlakis (2018) Healthcare logistics and supply chain – issues and future challenges, Supply Chain Forum: An International Journal, 19:1, 1-3, h

Beaulieu, M., S. Landry and J. Roy (2012). La productivité des activités de logistique hospitalière, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, mars 2012.
Vous devez chercher à positionner votre sujet.

Bourhis et Chênevert (2019) chapitre 1, 12 et 13
Les textes des chapitres 1, 12 et 13 du livre

Mary Catherine O'connor (6 février 2007),
https://www.rfidjournal.com/rfid-tidies-up-distribution-of-hospital-scrubs

Claire Swedberg (24 Septembre 2017),
https://www.rfidjournal.com/rfid-solution-cuts-scrubs-costs-for-virginia-hospital

Claire Swedberg (13 janvier 2020),
https://www.rfidjournal.com/hospital-prevents-contamination-and-gains-efficiency-via-rfid

Roger (31 Décembre), https://www.rfidfuture.com/fr/rfid-technology-in-hospitals.html#Introduction

ESG UQÀM

